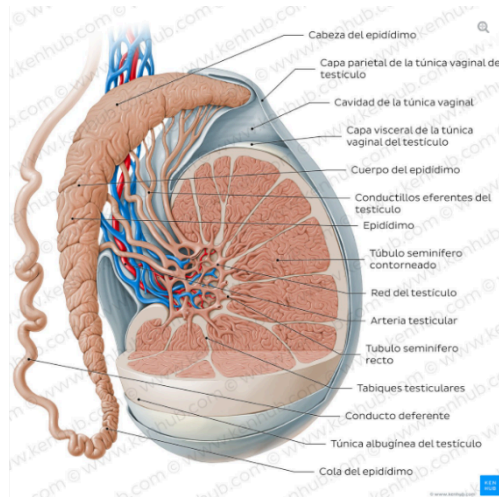


NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 4 semestre 2026A		CÓDIGO:	NIVEL DE PRÁCTICA:
NOMBRE DEL DOCENTE: Samuel Humberto Palacio Peña		ESCENARIO DE PRÁCTICA:	NOTA:
ESPECIALIDAD: Urología	CIRUJANO	FECHA:	
NOMBRE DEL PACIENTE:		NÚMERO HISTORIA CLÍNICA:	EDAD DEL PX:
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO PARA REALIZAR: HIDROCELECTOMIA			
PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA			
1. ETAPA DE PLANEACIÓN:			
1.1. Objetivo Quirúrgico: (Hacer descripción) El objetivo quirúrgico de la hidrocelectomía es eliminar una hidrocele, que es una acumulación anormal de líquido en el saco escrotal que rodea al testículo. Este procedimiento se realiza para aliviar el dolor, la incomodidad y el agrandamiento del escroto, así como para prevenir posibles complicaciones. La intervención quirúrgica está indicada cuando la hidrocele es grande, causa molestias significativas o se relaciona con otras patologías. El procedimiento consiste en realizar una incisión en el escroto o en la región inguinal para drenar el líquido acumulado. En muchos casos, se repara o se extirpa parte de la túnica vaginal (la membrana que recubre el testículo) para prevenir la recurrencia. La hidrocelectomía es una cirugía menor, generalmente segura y eficaz. La recuperación suele ser rápida y los riesgos de complicaciones son bajos, aunque pueden incluir infección, hematomas o inflamación.			



1.2. Anatomía y fisiología: (Hacer gráfico y descripción).

ANATOMIA

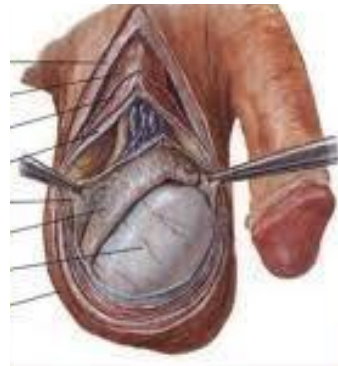


Los testículos son glándulas reproductoras masculinas localizadas en el escroto. Poseen forma ovoidea, con 4 a 6cm de longitud y con un peso de 10-15 gramos.

El escroto es usualmente asimétrico, con un testículo más inferior que el otro (usualmente el izquierdo). Los testículos están suspendidos dentro del escroto por el cordón espermático.

Capas del testículo

- Piel o escroto
- Dartos
- Capa celular subcutánea
- Fascia espermática externa
- Musculo cremáster
- Fascia espermática interna
- Túnica vaginal del testículo





Conductos espermáticos

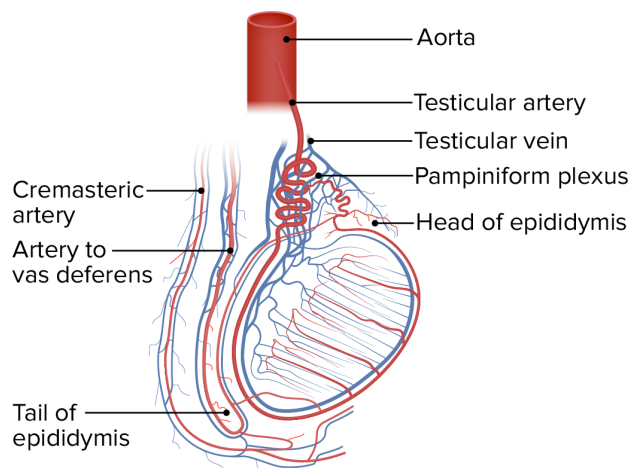
- Conductillos eferentes: Expulsan a los espermatozoides al conducto epidídimo
- Conducto del epidídimo: Maduración y almacenamiento de espermatozoides
- Conducto deferente: Involucrado en el transporte de los espermatozoides desde el epidídimo hacia los conductos eyaculadores.

Irrigación y drenaje venoso

- Arteria testicular
- Arteria cremastérica (rama de la arteria epigástrica inferior)
- Arteria del conducto deferente (rama de la arteria vesical inferior)
- Plexo pampiniforme y la vena testicular

Inervación

- Plexo testicular



FISIOLOGIA

Los testículos producen y almacenan las células germinales masculinas (espermatozoides) y secretan hormonas sexuales masculinas llamadas andrógenos (principalmente testosterona).



1.3. Lista de chequeo:

INSTRUMENTAL	EQUIPOS / DISPOSITIVOS MEDICO	SUTURAS Y AGUJAS	FARMACOS Y SOLUCIONES
Canasta de plastia	● Paquete de ropa ● Caucho de succión ● Frasco de patología ● Aseptojeringa ● Torundas ● Gasas ● Apósitos ● Compresas ● Hoja de bisturí # 15 ● Lapicero de electrobisturí ● Guantes ● Dren de Pen rose ● Frasco de patología ● Cánula de yankawer	PIEL: Polipropileno 2/0 o 3/0 con aguja 3/8 de circulo cortante con aguja de 27 mm. TCS: Poliglactina 910 2/0 con aguja ½ circulo redonda de 27 mm. Fascia y musculo: Poliglactina 910 1 o 0 con aguja ½ circulo redonda de 37 mm. Marzupialización: Poliglactina 910 4/0 con aguja ½ circulo redonda Escroto: Catgut cromado 3/0 o 4/0 con aguja ½ circulo redonda	Solución salina



1. ETAPA DE ORGANIZACIÓN:

- a. Arreglos de mesas de mayo y reserva (realizar esquema).

MESA DE MAYO



- 1) Mango de bisturí 3 - Hoja de bisturí #15
- 2) Tijeras de Metzembraum
- 3) Tijeras de Mayo recta
- 4) Pinzas Kelly curva
- 5) Pinzas Kelly recta
- 6) Pinzas Kelly Adson
- 7) Pinzas Rochester curva
- 8) Pinzas Rochester recta
- 9) Pinzas Allix
- 10) Pinza de Disección Rusa
- 11) Pinza de Disección sin garra larga
- 12) Pinza de Disección con garra larga
- 13) Pinza de Disección sin garra corta
- 14) Disección Adson con garra
- 15) Separadores de Farabeuf



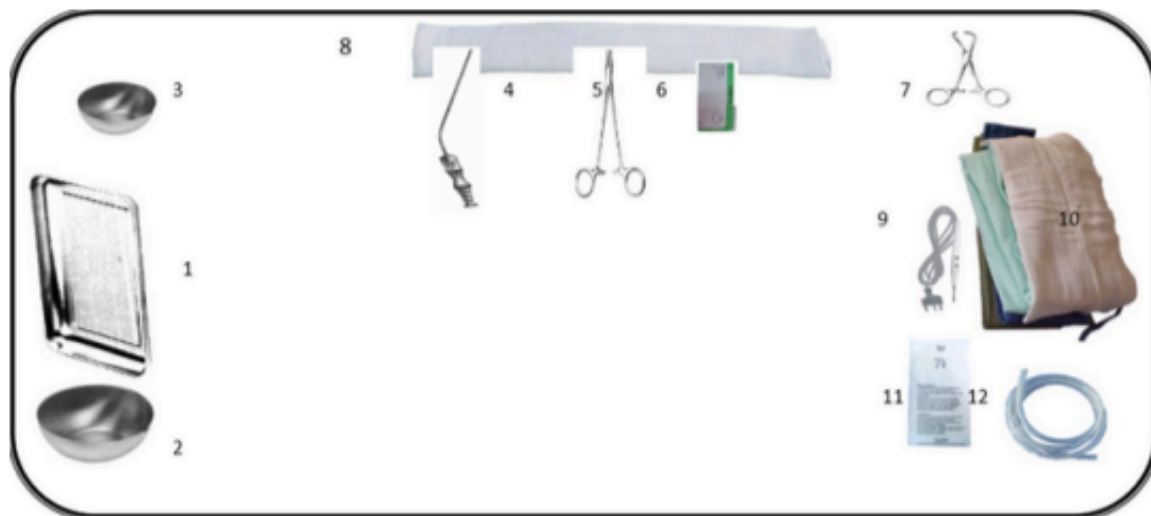
**Universidad
de Santander**
Personería Jur. 810 de 12/03/96 Min.Educación
UDES
VIGILADA MINEDUCACIÓN

PROGRAMA DE INSTRUMENTACION QUIRURGICA

PLANEAMIENTO QUIRURGICO FORMATIVA
IQX-FT-003-BUC

Versión: 1

MESA DE RESERVA



1. Canasta de plastia, 2. Coca con suero, 3. Coca, 4. Cánula de Yankauer, 5. Portaagujas, 6. Suturas, 7. Pinza de campo de Backhouse, 8. Compresa, 9. Lapicero del electrobisturí, 10. Paquete de ropa, 11. Guantes, 12. Caucho de succión.



**Universidad
de Santander**
Personería Jur. 810 de 12/03/96 Min.Educación
VIGILADA MINEDUCACIÓN **UDES**

PROGRAMA DE INSTRUMENTACION QUIRURGICA

PLANEAMIENTO QUIRURGICO FORMATIVA
IQX-FT-003-BUC

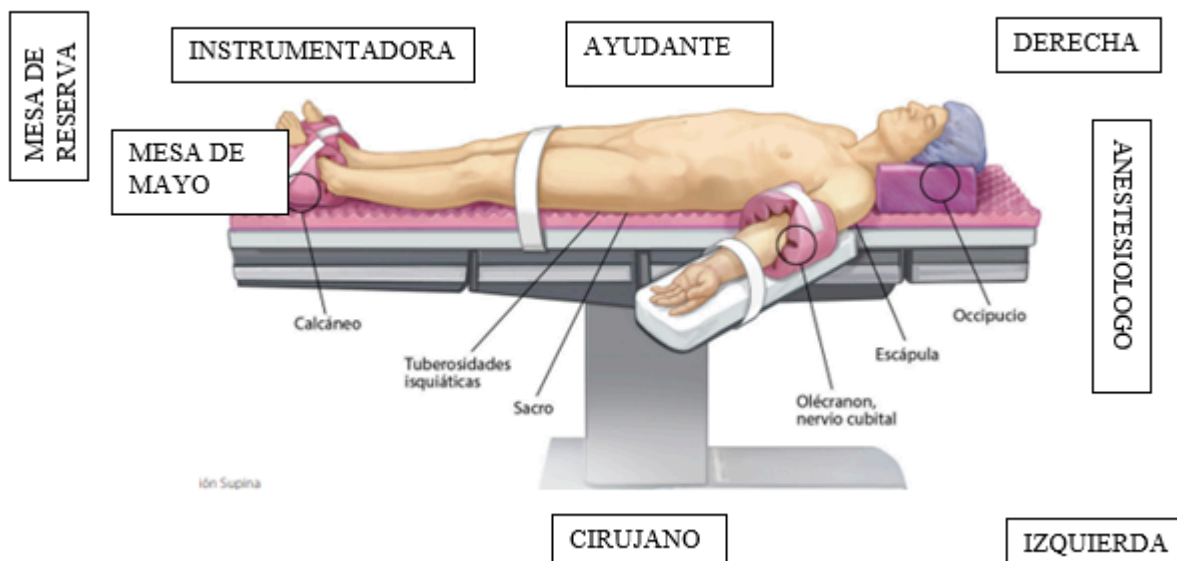
Versión: 1

2.2. Posición del paciente (Nombre y gráfico):

Decúbito supino



Ubicación del Equipo Quirúrgico (realizar gráfico)



2. ETAPA DE EJECUCION:

a) Anestesia (escribir el tipo de anestesia):

Anestesia raquídea y general





b) Incisión (escribir el tipo de abordaje y el nombre de la incisión):



FIGURA 3. Incisión transversa que respeta la vascularización escrotal superficial.



c) Proceso Quirúrgico (Describir los pasos principales de la técnica médico-quirúrgica con el instrumental a usar).

TÉCNICA QUIRÚRGICA	INSTRUMENTACIÓN
Incisión por vía escrotal por la túnica vaginal	Mango de bisturí #3 Hoja de bisturí #15
Disección roma del tejido celular subcutáneo hasta visualizar la túnica vaginal	Pinza Kelly curva Tijeras de metzenbaum
Separación y exposición del campo quirúrgico para mejor visualización	Separadores de farabeuf
Divulsión del músculo y tejidos adyacentes para exponer el saco hidrocelar	Pinza Kelly curva
Disección cuidadosa de estructuras espermáticas y liberación del saco hidrocelar	Pinza mosquito curva Pinza Adson con garra
Incisión de la túnica vaginal para acceder a la hidrocele.	Mango de bisturí #3 Hoja de bisturí #15



**Universidad
de Santander**
Personería Jur. 810 de 12/03/96 Min.Educación UDES
VIGILADA MINEDUCACIÓN

PROGRAMA DE INSTRUMENTACION QUIRURGICA

PLANEAMIENTO QUIRURGICO FORMATIVA
IQX-FT-003-BUC

Versión: 1

Aspiración y evacuación completa del líquido hidrocelar.	Cánula de frazier Caucho de succión
Sección y resección parcial del saco hidrocelar	Tijeras de plastia
Marzupialización o eversión del saco hidrocelar para evitar recidiva.	Porta agujas fino Poliglactina 910 4/0 con aguja ½ circulo redonda
Clampaje y ligadura de vasos sangrantes durante el procedimiento	Pinza Kelly
Verificación de hemostasia final del campo quirúrgico	Electrobisturí Pinza mosquito curva
Colocación de dren por contrabertura si se requiere drenaje postoperatorio	Dren Penrose
Cierre por planos del tejido y túnica	Poliglactina 910 2/0 con aguja ½ circulo redonda
Cierre de Tejido escrotal, cierre por planos y curación	Catgut cromado 3/0 o 4/0 con aguja ½ circulo redonda Polipropileno 2/0 o 3/0 con aguja 3/8 de circulo cortante

FORMATO DE INFORME SEMANAL DE LA PRACTICA FORMATIVA
FORMATO RECORD DE ASISTENCIA A CIRUGIA - PRACTICA FORMATIVA
IQX-FT-024-UES

FIRMA ESTUDIANTE: _____

FIRMA DOCENTE: _____